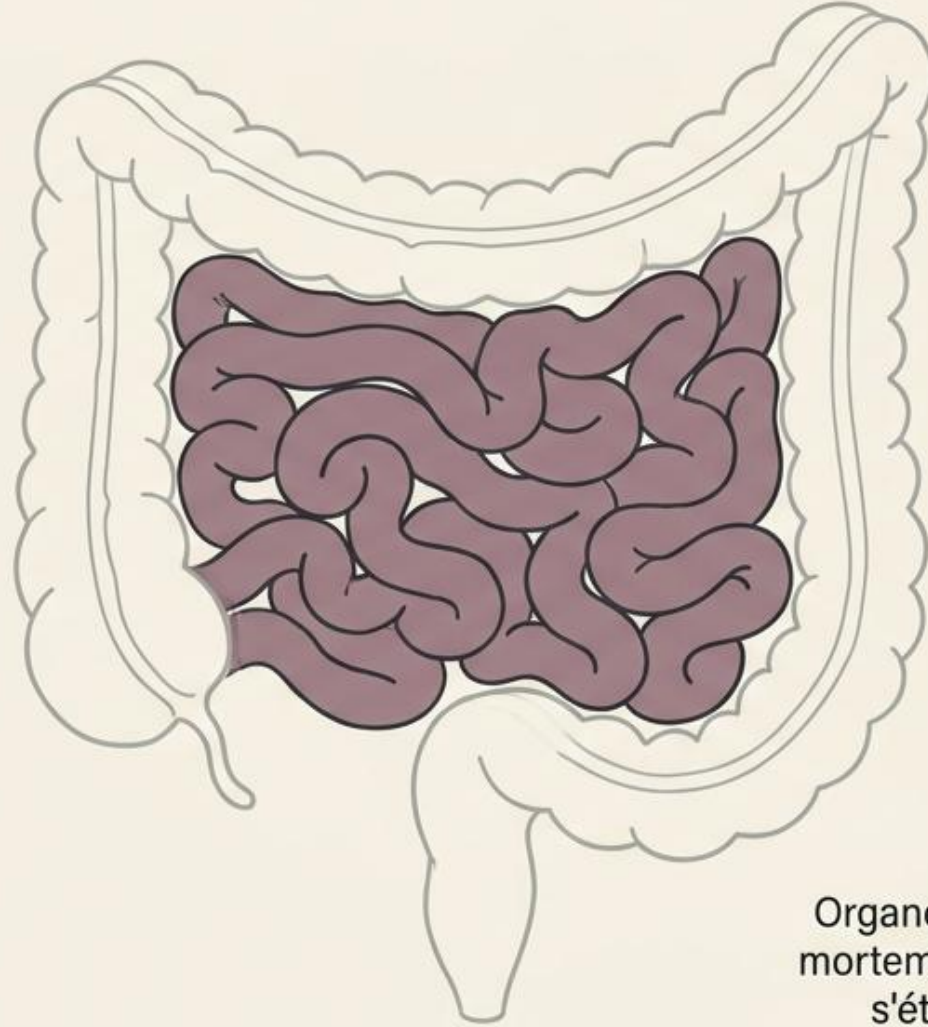


L'Intestin Grêle : Anatomie, Écosystème et Approche ROP

Chapitre 14 — Le carrefour systémique, mécanique, neurologique et immunitaire.

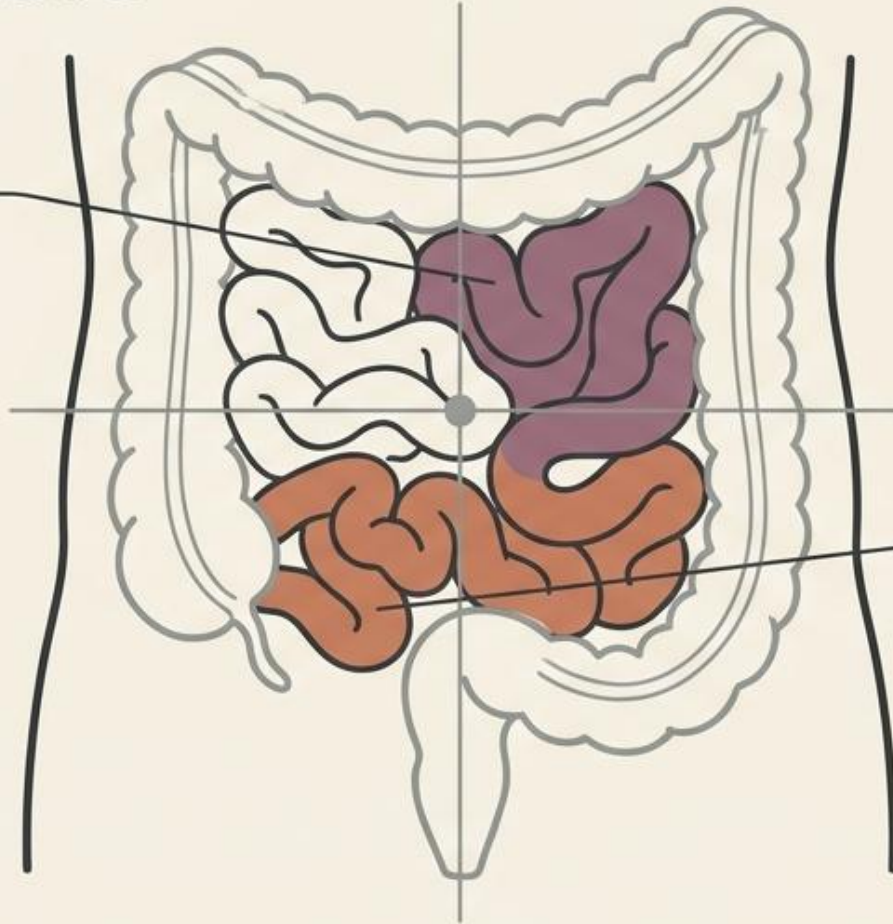


Organe le plus long du corps (6 à 7 mètres post-mortem, rétracté in vivo par le tonus musculaire), s'étendant du pylore à la valvule iléo-cæcale.

Topographie et disposition intra-abdominale

Jéjunum

- Quadrant supérieur gauche
- Recouvre le côlon descendant
- Orientations vasculaires et anses majoritairement horizontales

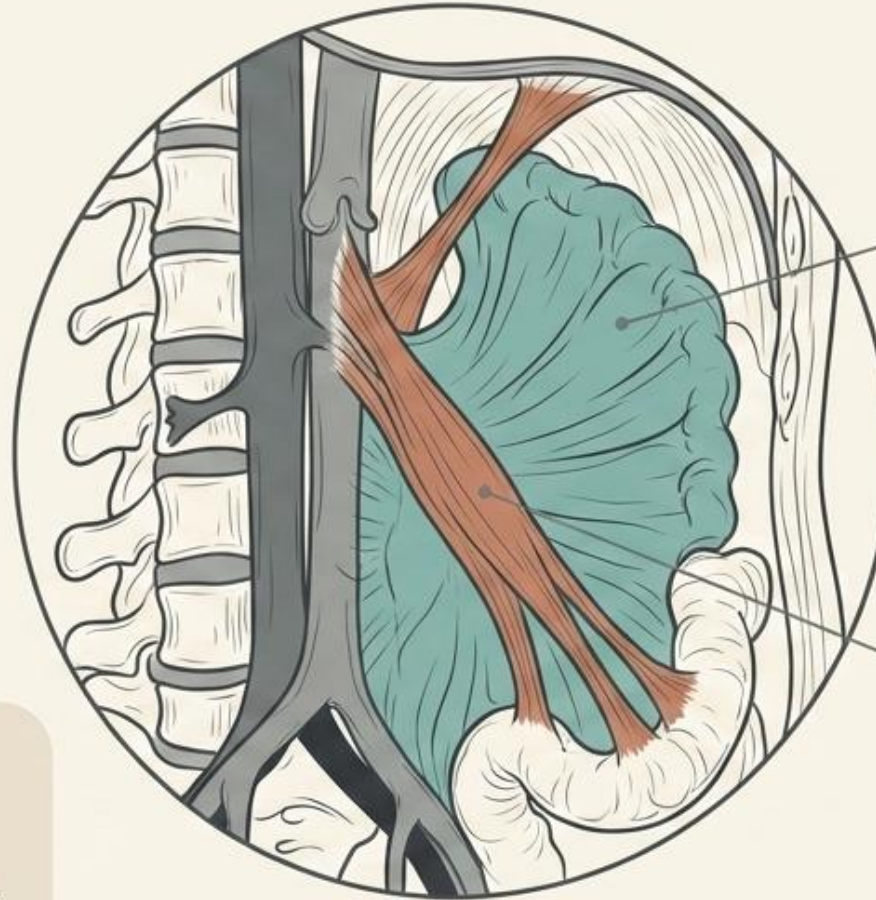


Iléum

- Quadrant inférieur droit
- Laisse libre le côlon ascendant
- Orientations vasculaires et anses majoritairement verticales

Longueur cadavérique : 6 à 7 mètres. Lumière : 2 à 3 cm de diamètre.
Organe intra-péritonéal extrêmement mobile.

L'Ancrage Mécanique : Mésentère et Muscle de Treitz



• Racine du mésentère

Ligne d'attache de 16 à 18 cm, croisant l'ombilic en L3-L4. Assure la stabilité et transporte vaisseaux/nerfs.

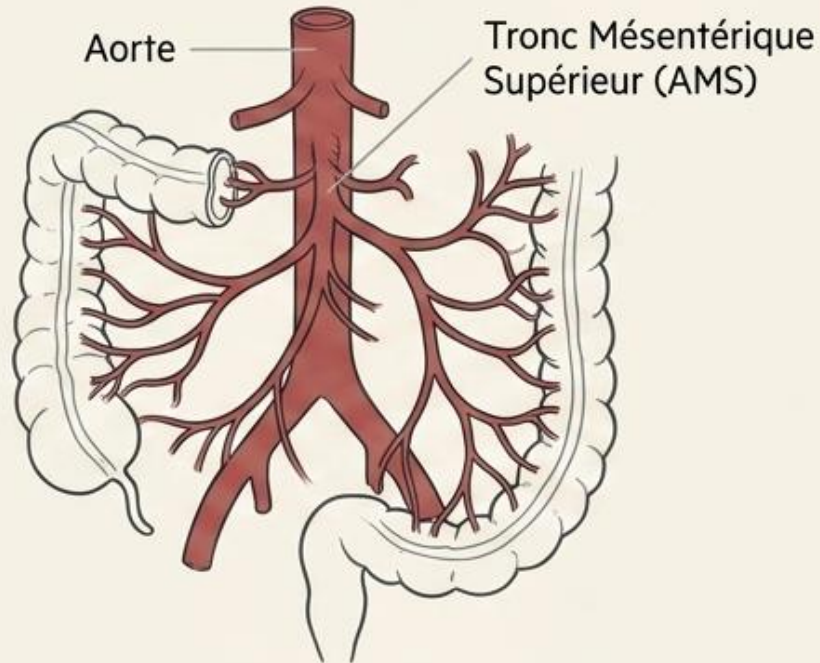
• Muscle de Treitz

S'attache au pilier droit du diaphragme. Maintient l'angle duodéno-jéjunal et assure la tension longitudinale.

Syndrome de la Pince Aorto-Mésentérique

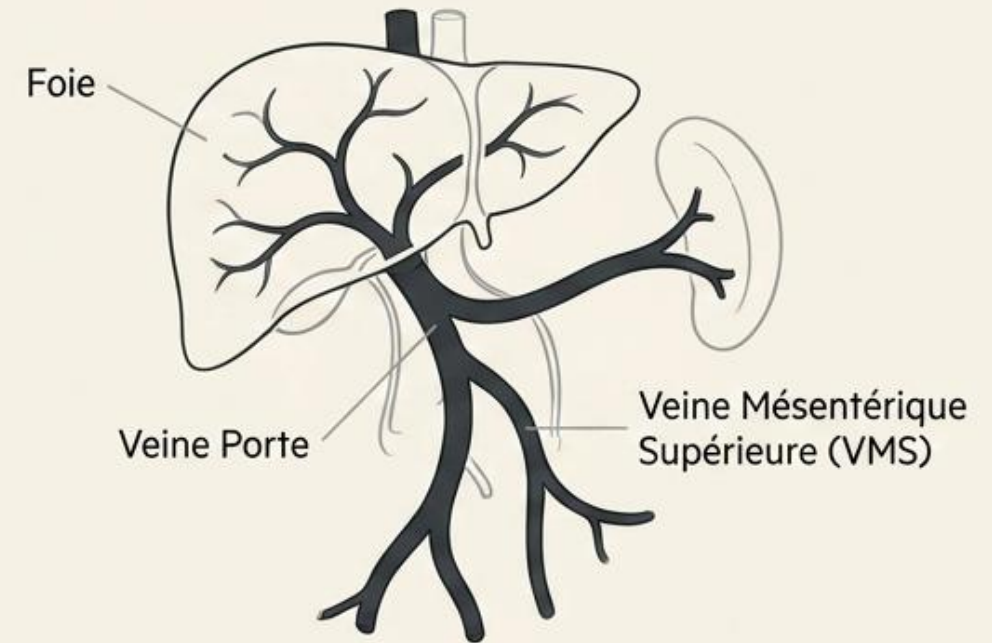
Une perte de tension longitudinale peut entraîner une compression du 4ème duodénum (nutcracker syndrome), retardant l'évacuation et favorisant le reflux gastro-duodéal.

L'axe de l'irrigation et du drainage : Tronc Mésentérique Supérieur



Apport Artériel (Artère mésentérique supérieure)

- Origine : Disque Th12-L1 (sous le tronc cœliaque)
- Irrigue l'intestin grêle, le côlon ascendant et les 2/3 proximaux du transverse



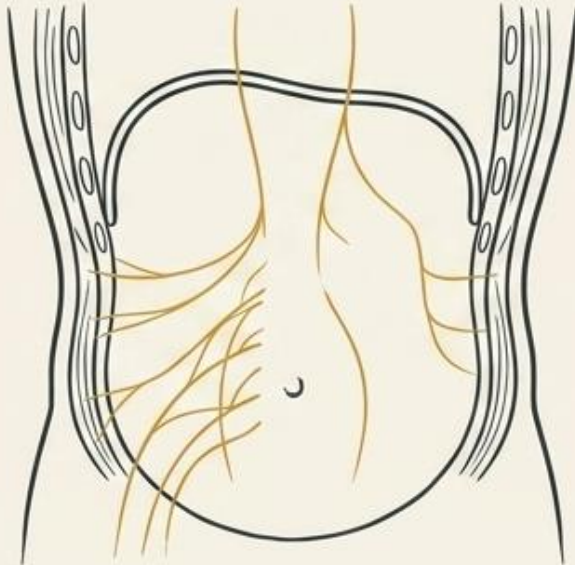
Drainage Veineux (Système Porte)

- Transporte le sang veineux chargé des nutriments absorbés directement vers le foie pour détoxification et métabolisation.

Note Pratique : Le pouls de l'AMS est perceptible au niveau du 3ème duodénum, à droite de l'ombilic.

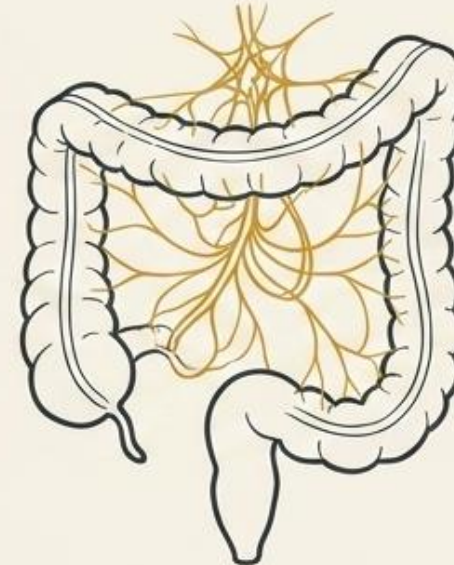
La double réalité neurologique du péritoine

Péritoine Pariétal (Innervation Somatique)



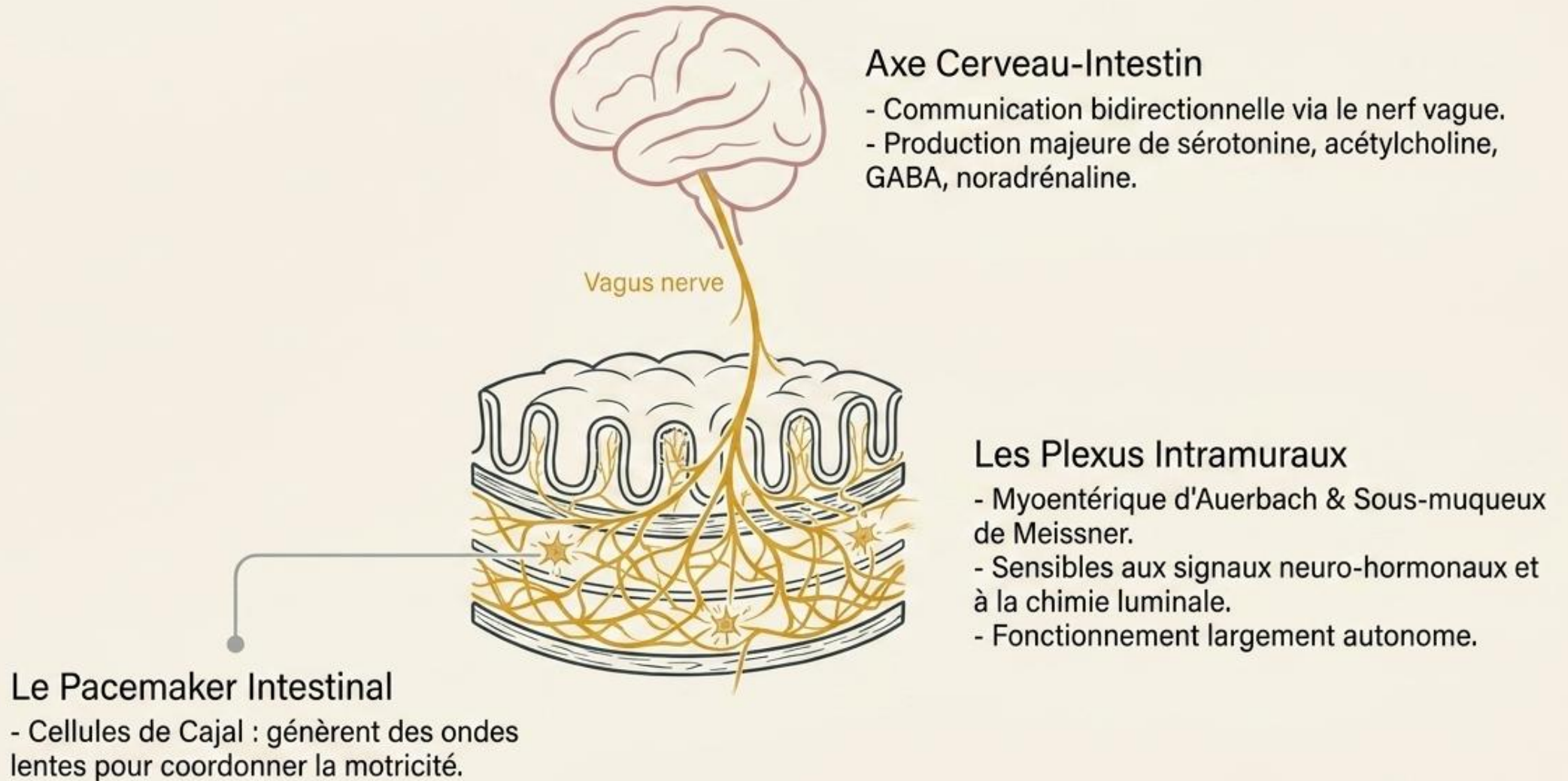
- Voies : Nerfs phréniques, 6 derniers intercostaux, plexus lombaire.
- Sensibilité : Aiguë (douleur, pression, température).
- Implication ROP : Projection des douleurs péritonéales vers le système ostéo-musculo-articulaire (cervicales, lombaires, scapulaires).

Péritoine Viscéral (Innervation Autonome)



- Voies : Système Sympathique (Th8-Th11, nerfs splanchniques) et Parasympathique (Nerf Vague).
- Sensibilité : Faible au toucher/section. Stimulée par l'étirement (distension) et la chimie.
- Implication ROP : Le Sympathique inhibe le péristaltisme (stress) ; le Vague le favorise.

Le Deuxième Cerveau : Autonomie du Système Nerveux Entérique (SNE)



Le "Deuxième Cerveau" : Système Nerveux Entérique

Plexus Intra-Muraux

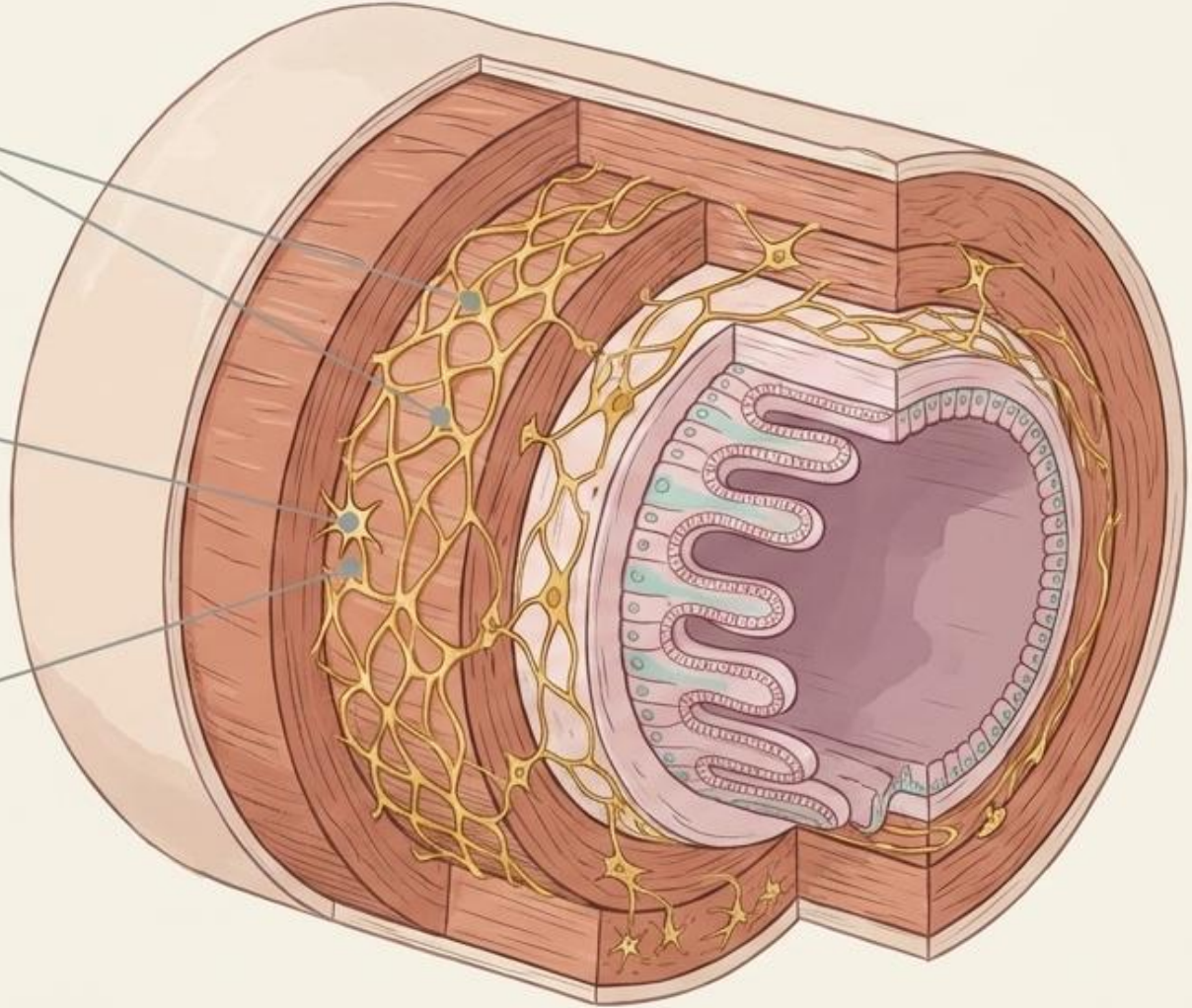
Plexus myentérique d'Auerbach et sous-muqueux de Meissner. Assurent une régulation quasi autonome des fonctions digestives.

Cellules de Cajal

Le pacemaker intestinal. Génèrent des ondes lentes qui coordonnent la motricité indépendamment du péristaltisme induit par le chyme.

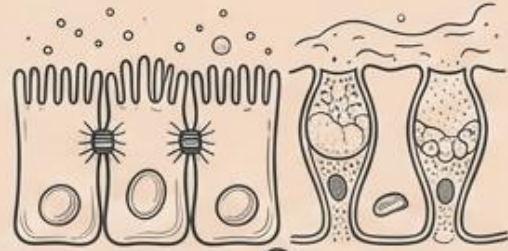
Production Neurochimique

Synthèse majeure de sérotonine (régulation de l'humeur partagée avec le cerveau), d'acétylcholine, de noradrénaline et de GABA.



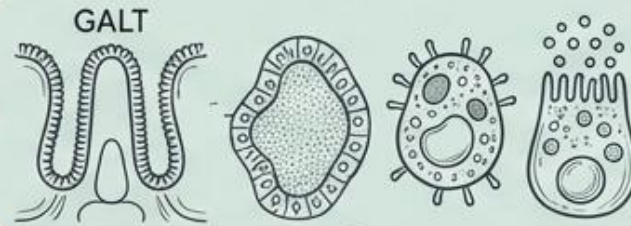
L'Écosystème intestinal :

Le trépied de la santé digestive



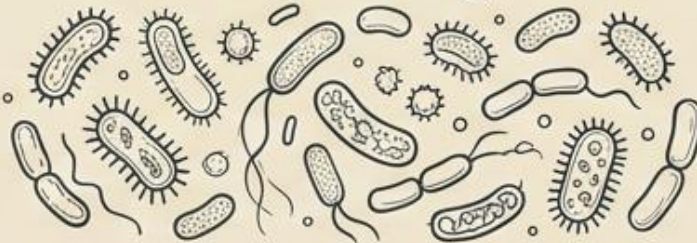
1. Muqueuse Intestinale (Interface)

- Entérocytes avec desmosomes (jonctions serrées).
- Cellules caliciformes (production de mucus protecteur).



2. Système Immunitaire (Défense)

- GALT (Gut Associated Lymphoid Tissue) et Plaques de Peyer.
- Mastocytes et Cellules de Paneth (peptides antimicrobiens).



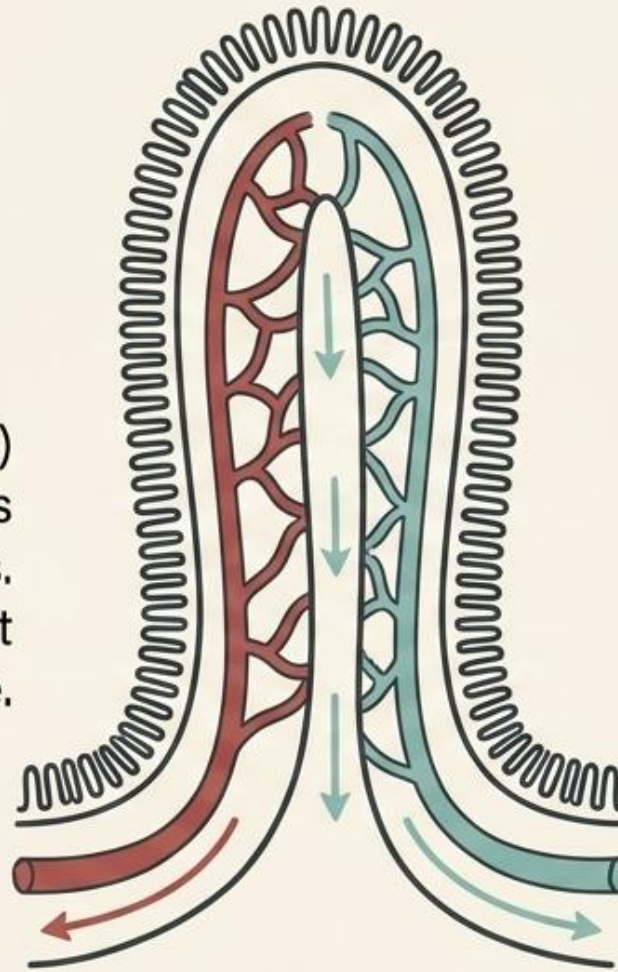
3. Microbiote (Symbiose)

- ~38 milliards de bactéries par organisme.
- Signature unique dès la naissance. Participe à l'immunité, la digestion, et l'axe intestin-cerveau.

La Double Voie d'Absorption Micronutritionnelle

Voie Sanguine (Capillaires)

- Absorbés : Eau, oses simples, acides aminés, vitamines hydrosolubles.
- Destination : Acheminés directement vers le foie via le système porte.



Voie Lymphatique (Chylifères)

- Absorbés : Graisses, protéines à chaîne longue, vitamines liposolubles (A, D, E, K).
- Destination : Réseau lymphatique -> Citerne de Pecquet -> Canal thoracique.



Intérêt en ROP : Une action réflexe podale sur le foie et le système lymphatique soutient qualitativement l'absorption et l'immunité.

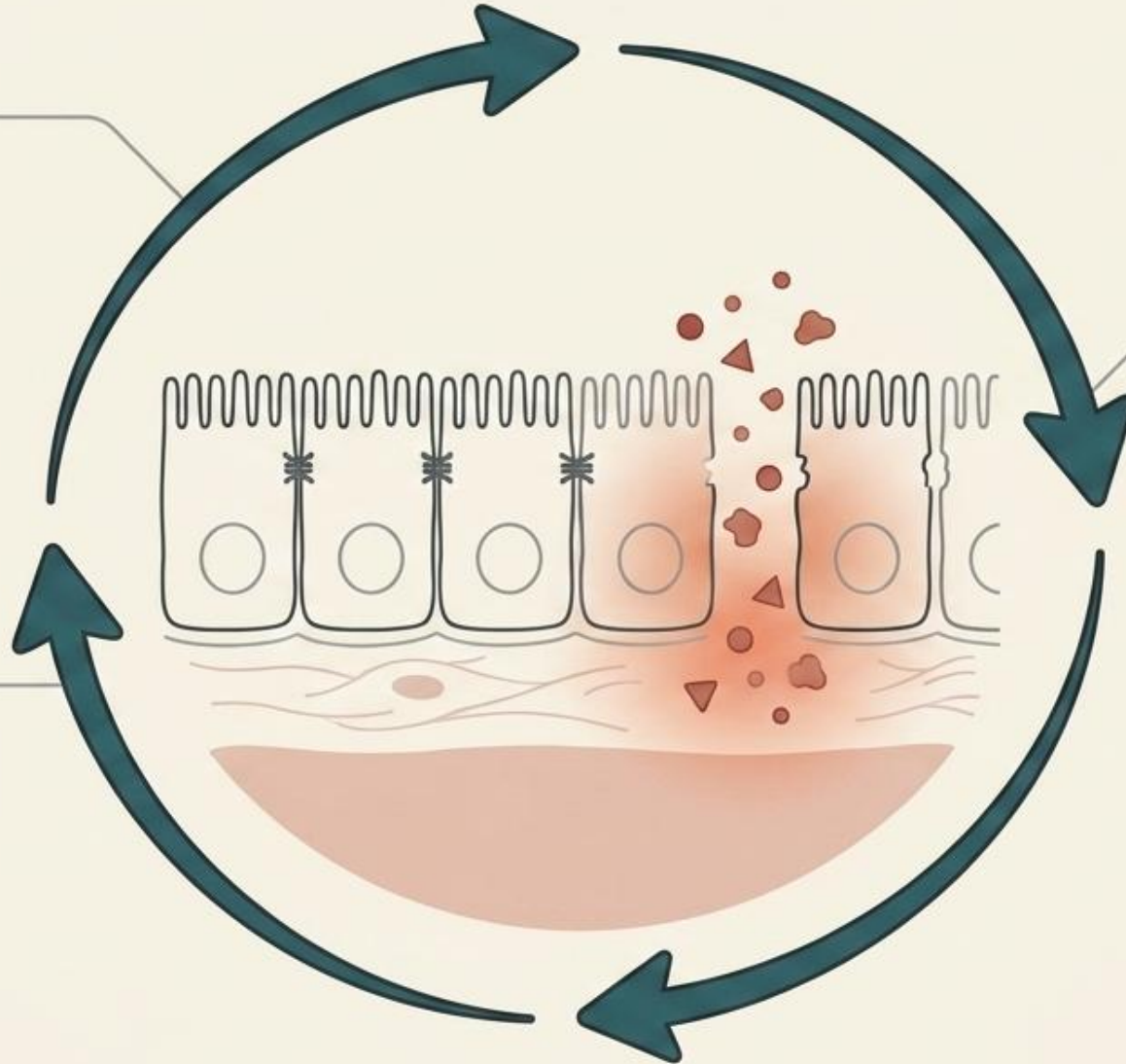
La Spirale : Dysbiose et Hyperperméabilité

Déclencheurs

Stress chronique (vasoconstriction sympathique), aliments ultra-transformés, AINS, antibiotiques.

Hyperperméabilité

Altération des jonctions serrées. Passage de toxines et protéines incomplètement dégradées, déclenchant l'inflammation.



Conséquences Systémiques

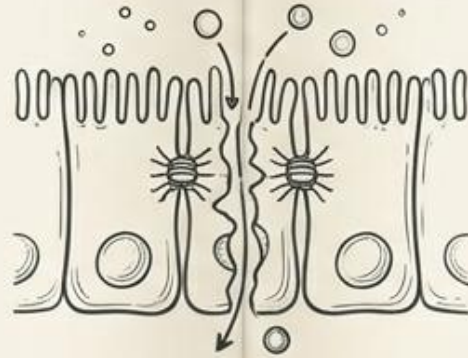
Surcharge hépatique (théorie de l'engrassement de Seignalet). Le foie saturé redirige les déchets vers les tissus, provoquant douleurs ostéo-articulaires, tendineuses et allergies.

Pathologie I : L'Hyperperméabilité intestinale (Leaky Gut)

Causes (Agressions)

- Stress chronique (vasoconstriction par le Sympathique)
- AINS / Antibiotiques
- Alimentation ultra-transformée
- Sports d'endurance extrêmes

Mécanisme (Rupture)



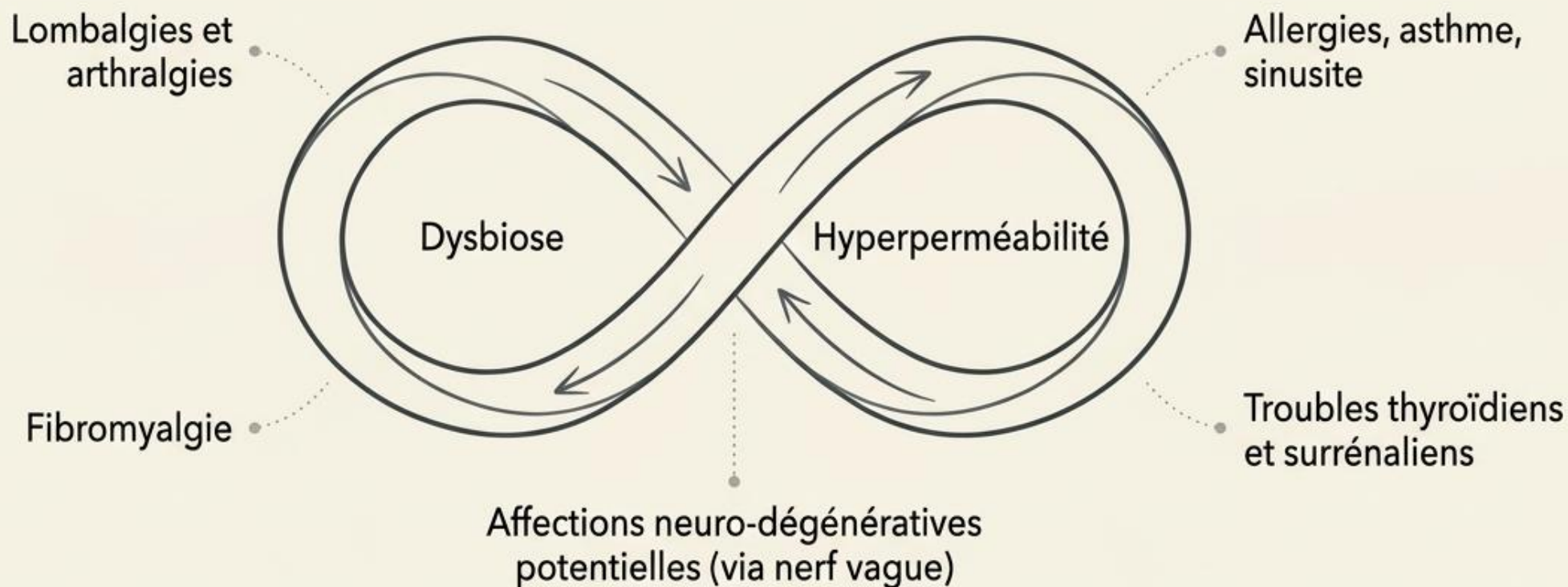
Altération des jonctions intercellulaires → Passage de macromolécules insuffisamment dégradées.

Conséquences (Systémiques)

- Activation immunitaire (Allergies, maladies auto-immunes).
- Surcharge hépatique (Théorie de l'engrassement du Dr Seignalet : dépôt de toxines dans les muscles, articulations, cerveau).

Intérêt ROP : Devant des douleurs ostéo-articulaires sans traumatisme évident, toujours suspecter un lien avec une dysfonction viscérale.

Pathologie II : La Dysbiose et ses manifestations



Signes annonciateurs : Météorisme, aérocolie, alternance diarrhée/constipation, pyrosis, attirance anormale pour le sucre/viande crue, haleine chargée.

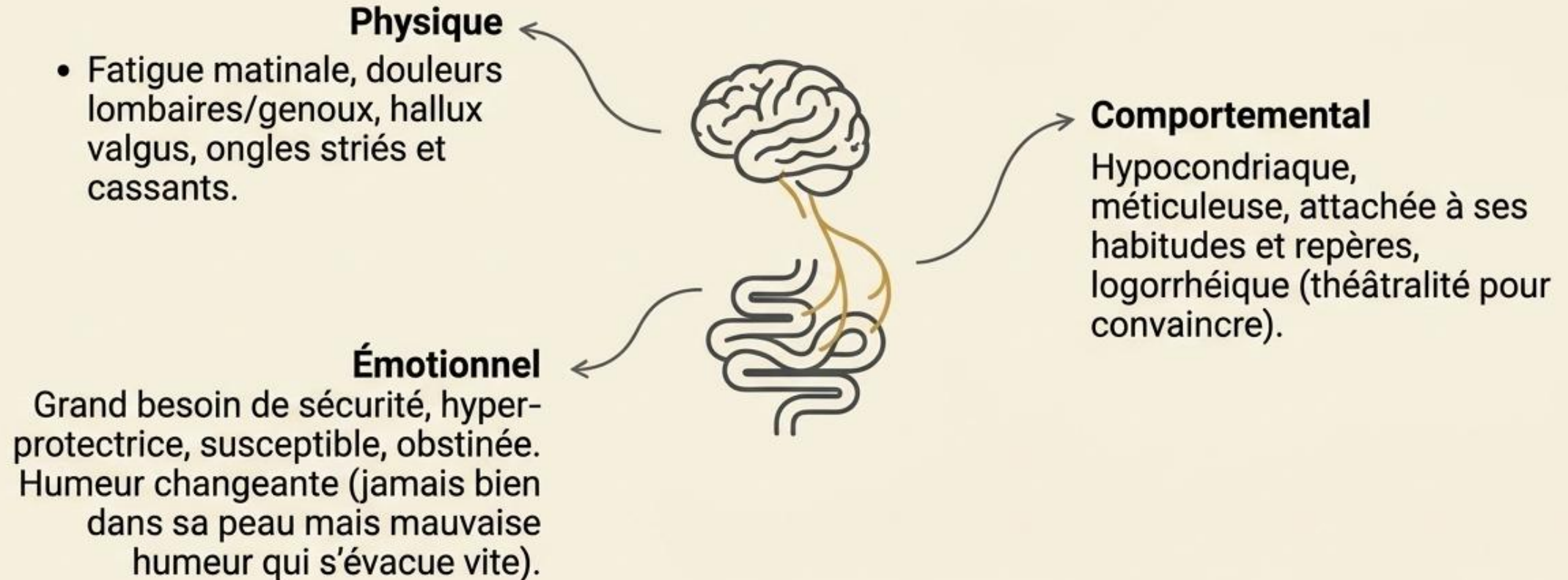
Note : Corrélation $\neq$ Causalité (Pr Sokol) : les deux troubles cohabitent et s'entretiennent mutuellement.

Signes d'Alerte et Diagnostic d'Exclusion

Orientation Médicale Impérative en présence de :

- - Fièvre, sang rouge ou noir dans les selles.
- - Perte de poids importante et inexpliquée.
- - Ganglion de Troisier (carrefour jugulo-subclavier gauche) : suspicion oncologique.
- - Signe du glaçon : évocateur d'une ascite.
- - Hernie inguinale étranglée irréductible.
- - Occlusion / Iléus : Arrêt des matières et gaz. Peut être mécanique (tumeur, bride) ou paralytique (atonie par irritation péritonéale).

Profil viscéro-émotionnel : La Personne Intestin



Note : Très hormono-dépendant (surtout chez la femme). L'intestin grêle est le récepteur-émetteur privilégié des tensions émotionnelles, favorisant l'hyperactivité sympathique.

Stratégie ROP 1 : Régulation du Système Nerveux et Liens Somatiques



Relations Viscéro-Somatiques

- Fixations vertébrales cibles : Th10 à Th12 (et côtes associées), L1 et L2.



Zones Réflexes Podales - Syndrome d'Adaptation

- Nerf Vague : Territoire crânien, cervical et abdominal (hiatus oesophagien, cardia).
- Système Sympathique : Chaîne ganglionnaire latéro-vertébrale (Th8-Th10) et piliers du diaphragme.
- Plexus Solaire (Coélique) & Plexus Lombaire.
- Induction Système Limbique : Technique de balance Cerveau Limbique-Intestin pour réguler l'axe viscéro-émotionnel.

Accompagnement ROP des Pathologies Fonctionnelles



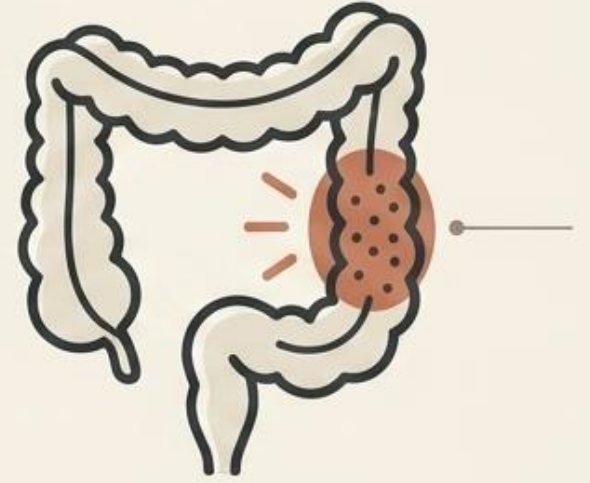
Entéroptoses

La masse entérique attirée vers le bas entraîne stases veineuses/lymphatiques, spasmes nerveux et pression sur la vessie (fuites urinaires). L'action ROP vise à restaurer la tension de la racine mésentérique.



Iléus Paralytique

Inhibition de motricité par dominante sympathique (post-chirurgie, choc, hypokaliémie). Sans douleur de distension. L'induction vise à relancer le Vague.



Maladie de Crohn

Composantes génétiques, dysbiotiques et émotionnelles. L'approche ROP contribue à soulager les douleurs abdomino-pelviennes et à soutenir un meilleur transit.

Synthèse d'Intervention ROP : Protocole Intestin Grêle

Step 1: Écoute et Induction (Système Limbique)

Action : Un pouce sur la zone Intestin Grêle, l'autre sur la zone Cerveau Limbique.

Objectif : Apaiser la charge viscéro-émotionnelle (stress, anxiété, besoin de sécurité) et relancer le tonus vagal.



Step 2: Libération Structurale (Relations Viscéro-Somatiques)

Action : Traitement des fixations vertébrales et costales.

Zones cibles : Charnière Th10-Th12 (Sympathique) et L1-L2 (Plexus lombaire, racine du mésentère).



Step 3: Traitement Locorégional (Viscéral)

Action : Levée des tensions de suspension et stimulation du péristaltisme.

Zones cibles : Diaphragme (Treitz), Estomac (réflexe), Racine du mésentère (tension longitudinale), et cartographie Jéjunum/Iléum.

L'approche ROP restaure la mobilité, l'innervation et l'écosystème : une réponse globale à la maxime 'Toute maladie commence dans l'intestin'